

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA			
NS 22231697071		857	
LIVIA SENIS CARDOSO MACEDO <i>filha de Dr. Ivan</i>			
IDADE: 38	PESO: 75	ALTURA: 1,76	PROFISSÃO: Adm Empresas <i>Macedo</i>
SINTOMAS: <i>Enxaqueca crônica de crises</i>		<i>→ controla internamente, auditiva</i>	
QUEIXAS: <i>Qualidade sono ruim; apnéia; Insônia; muito despertares</i>			
MEDICAMENTOS: <i>Donarem; Sínchroid (ferrugem); Glifage (cálcio polidifosfato)</i>			
MÉDICO: <i>Dr. Nairão Panarua (Piquetara) / Dr. Ivan</i>			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: <i>na faz.</i> 18h30 19h			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S		ALMOÇO: S	LANCHE: S JANTAR: N
HORA QUE DORME: <i>23h</i>		HORA QUE ACORDA: <i>6h30'</i>	
COCHILHO () S ☒ N	DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE		
TEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N		PET NO QUARTO: ☒ S () N	
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N		<i>cachaço</i>	
FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIRO/NOITE: <i>L</i>	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: <i>Ama</i>	MALLAMPATI: <i>I</i>	IAH: <i>40,91/h</i>	SPO2: <i>53%</i>
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: <i>Hto de Piquetara - Depressão; Ama se faz uso de simbiótico na cura</i>			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: <i>Assintomática</i>			
COMORBIDADE: ☒ RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA	(S) NEUROLÓGICA	() OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N		SPO2 C/ CPAP:	PRESSÃO NO EXAME:
<i>23/10/2024 Aveliaç.</i>		<i>Auto 4 a 10 cmH2O másc Dream Wear (S)</i>	
<i>31/10</i>	<i>P = 5,4 mediano / perc. 74 cmH2O</i>		
<i>24</i>	<i>IAH = 3,3</i>		
	<i>Fuga = 7h20'</i>		
	<i>Relata ter ido ao banheiro 2x.</i>		
	<i>Acorda com dificuldade.</i>		
<i>25/11</i>	<i>P = 6,0 cmH2O (↑ escape)</i>		
<i>24</i>	<i>IAH = 3,6</i>		
	<i>m. de uso = 6:44</i>		
	<i>fuga = 0,3 lpm.</i>		
<i>16/12/24</i>	<i>P = 6,0 cmH2O relata estar dormindo muito bem</i>		
	<i>IAH = 3,6 2lh</i>		
	<i>curso = 3h07min → Alergia no rosto ao xilicone +</i>		
	<i>fuga 15l/min → levou Airmini p/ teste. Siena</i>		

07/02/25 * comprou CPAP básico *

31/05/25 Retirou o mini.



Clinica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Livia Senis Cardoso Macedo

EXAME nº: 5619

SOLICITADO POR: Dr. Mário César de Souza Bazzarella

DATA: 29/09/2024

IDADE: 38 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h01min e concluído às 06h07min. A latência para o sono foi de 15 minutos e a latência para o estágio REM, de 205 minutos. O tempo total de sono foi de 438,5 minutos (07h18min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 90,7%. A distribuição do sono registrado mostrou 8,8% de estágio 1, 59,4% de estágio 2, 15,4% de estágio 3 e 16,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 29,5 minutos em vigília, ocorreram 97 microdespertares (índice: 13,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 40,9/hora, sendo 0,6 apneia/hora e 40,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 45,4/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 90% e a mínima de 53%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono

TTR ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (40,9/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (45,4/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM, e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 79; máxima: 102 bpm.

O ronco foi intermitente e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 15 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (205 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (90,7%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (13,3/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (8,8%; normal: 5%) e 2 (59,4%; normal: 45-55%), e a redução do estágio REM (16,4%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 3 (15,4%; normal: 15-16%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 0 (normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52

Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos

Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69.730